

1 間質性肺疾患・肝障害の薬薬連携 — 症状と検査値をつなぐ

病院薬剤師	病院と共有する情報	保険薬局薬剤師
① 投与前の胸部画像・KL-6・既往歴の確認	既往・リスク因子 (間質性肺炎・肝疾患)	① 咳・息切れ・発熱を来局ごとに同じ質問で聴取
② HBs抗原・HbC抗体のスクリーニングと予防投与の計画	肝機能の推移 (処方箋の検査値)	② 処方箋の検査値でAST・ALT・ビリルビンの推移を確認
③ ILD発症時の中止判断・ステロイド治療と再投与の検討	HBVの状態 (抗ウイルス薬・HBV-DNA)	③ 抗ウイルス薬(エンテカビル等)の継続を確認
④ 肝機能に応じた減量・休薬の判断	咳・息切れの有無 (電話フォローの結果)	④ 漢方薬・健康食品・市販薬の使用を確認
⑤ ICIの肺臓炎・肝炎への院内対応		⑤ 喫煙状況の確認と禁煙の支援

2 早期発見のポイント — 症状と検査値

間質性肺疾患	薬剤性肝障害	HBV再活性化
気づくための症状 空咳、階段や坂道での息切れ、発熱	気づくための症状 だるさ、食欲低下、黄疸、尿の色が濃い	気づくための症状 多くは無症状(肝炎になるまで気づかない)
確認する検査値 SpO2、胸部画像、KL-6	確認する検査値 AST・ALT・総ビリルビン	確認する検査値 HBs抗原・HbC抗体・HBV-DNA
薬局で確認すること 来局ごとに同じ質問で聞き取り、症状があれば至急受診	薬局で確認すること 処方箋の検査値の推移。開始後2~3か月は特に注意	薬局で確認すること 抗ウイルス薬の継続、HBV-DNA測定の予定
ICIの肺臓炎・肝炎	漢方薬・健康食品	
気づくための症状 咳・息切れ、だるさ・黄疸	気づくための症状 咳・息切れ、だるさ	
確認する検査値 胸部画像、AST・ALT	確認する検査値 —	
薬局で確認すること 治療終了後にも起こるため投与歴を確認	薬局で確認すること 小柴胡湯など間質性肺炎の報告がある漢方薬、健康食品の使用を確認	

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サブリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
注意 添付文書併用注意	ラパチニブ CYP3A4阻害	処方薬 クラリスロマイシン・アゾール系抗真菌薬	血中濃度↑ → 肝障害・下痢↑	他院の抗菌薬・抗真菌薬の処方を確認
注意 添付文書併用注意	レゴラフェニブ CYP3A4誘導	処方薬 サブリ・食品 リファンピシン・セイヨウオトギリソウ	血中濃度↓ → 効果減弱	他院の処方とサプリメントを確認
注意 添付文書併用注意	エベロリムス CYP3A4阻害	処方薬 サブリ・食品 アゾール系抗真菌薬・グレープフルーツ	血中濃度↑ → 口内炎・肺炎↑	抗菌薬の処方と食品を確認
注意 添付文書併用注意	パゾパニブ 胃内pH上昇で吸収低下	処方薬 市販薬 PPI・H2ブロッカー	血中濃度↓ → 効果減弱	市販の胃薬も含めて確認
確認 服薬指導上の注意	抗がん薬全般 肺・肝臓への影響の重複	市販薬 サブリ・食品 小柴胡湯などの漢方薬・健康食品	間質性肺炎・肝障害の報告	使用を確認し、開始前に相談するよう指導

4 服薬指導タイムライン — 肺と肝臓を見守る

① 治療開始前	② 開始~4週	③ 開始~2か月	④ 長期・治療終了後
“咳や息切れ、だるさなど、肺や肝臓の副作用のサインを先にお伝えしておきます”	“空咳や、階段で息が切れるといった変化があれば、次の受診を待たずに連絡してください”	“だるさや食欲の低下、尿の色が濃い、白目が黄色いといったことはありませんか”	“治療が終わってからも、咳や息切れ、だるさが出たら教えてください”
✓薬局で確認 間質性肺炎・肝疾患の既往、喫煙歴、HBV検査の結果、漢方薬・健康食品	✓薬局で確認 咳・息切れ・発熱の有無(電話フォロー)	✓薬局で確認 処方箋の検査値でAST・ALT・総ビリルビンの推移	✓薬局で確認 ICIの投与歴、抗ウイルス薬の継続とHBV-DNA測定の予定
△ここに注意 間質性肺炎の既往がある方はリスクが高い	△ここに注意 空咳・息切れ・発熱はILDを疑い至急受診	△ここに注意 黄疸・強いだるさは至急連絡	△ここに注意 抗ウイルス薬は自己判断で中止しない